Vieillissement physiologique et pathologique

Support de travail établi à partir des documents transmis. Le rattachement Moodle a été vérifié sur la liste des ressources ; les fichiers Moodle non récupérés et les commentaires audio ne sont pas déclarés intégralement contrôlés.

VIEILLISSEMENT PHYSIOLOGIQUE ET PATHOLOGIQUE

UE B1 — Cours unique de révision IFSI

Objectifs du cours

Distinguer vieillissement physiologique, fragilité, vieillissement pathologique et décompensation.

Comprendre le concept de syndrome gériatrique et la cascade gériatrique.

Reconnaître les principaux syndromes gériatriques : confusion, troubles neurocognitifs, dénutrition, déshydratation, chutes, incontinence, immobilisation et escarres.

Identifier les facteurs prédisposants, les causes ou facteurs précipitants et les complications.

Connaître les grands principes de prise en soins, notamment les mesures non médicamenteuses et préventives.

Repérer et prévenir la perte d’autonomie et la dépendance iatrogène ; préciser le rôle de l’IDE.

1. Comprendre le vieillissement

1.1 Définitions indispensables

Gérontologie : étude du vieillissement dans toutes ses dimensions : biologique, médicale, psychologique, sociale, démographique…

Gériatrie : spécialité médicale consacrée à la santé et aux soins des personnes âgées, notamment lorsqu’elles présentent des situations complexes.

Espérance de vie : nombre moyen d’années qu’une personne peut espérer vivre selon les conditions de mortalité observées.

Espérance de vie sans incapacité : années restant à vivre sans limitation importante d’activité ou incapacité.

Longévité : durée de vie atteinte par un individu ou durée de vie potentielle/maximale selon le contexte.

Vieillissement physiologique : processus universel, progressif et irréversible, caractérisé par une diminution progressive des réserves fonctionnelles, une diminution de la capacité à s’adapter à un stress aigu et une grande variabilité interindividuelle.

Vieillissement pathologique : vieillissement marqué par l’apparition de maladies et de syndromes gériatriques, avec diminution supplémentaire des réserves fonctionnelles et risque de décompensation.

Le vieillissement physiologique est universel, progressif et hétérogène. L'adaptation normale permet le maintien de l'autonomie fonctionnelle. Un déclin rapide ou une perte d'autonomie brutale constitue un signe d'alerte et ne doit pas être attribué au seul âge.

1.2 Âge chronologique et vieillissement en santé

60 ans

Signification dans le cours : Définition démographique/internationale

65 ans

Signification dans le cours : Seuil démographique couramment utilisé en France et en Europe

> 85 ans

Signification dans le cours : Âge moyen d'entrée en EHPAD

L'âge chronologique ne correspond pas à lui seul à l'état fonctionnel. Les trajectoires de vieillissement sont hétérogènes. L'objectif est de préserver les capacités fonctionnelles et l'autonomie.

Vieillissement réussi : maintien des capacités.

Vieillissement fragile : diminution légère à modérée des capacités et vulnérabilité accrue.

Vieillissement pathologique : diminution sévère des capacités, maladie et/ou dépendance.

1.3 Le patient gériatrique

Il est fréquemment caractérisé par l'association de :

âge avancé, souvent ≥ 75 ans

polypathologie

fragilité / diminution des réserves fonctionnelles

risque ou présence de perte d'autonomie

complexité médico-psycho-sociale

2. Modifications physiologiques liées au vieillissement

2.1 Appareil locomoteur

Sarcopénie : perte de masse et de force musculaire.

La masse osseuse diminue avec un risque d'ostéoporose. Les troubles de mobilité et d'équilibre augmentent le risque de chute. La prévention repose sur l'exercice, l'aménagement, la surveillance et l'accompagnement infirmier afin de maintenir l'autonomie.

2.2 Vieillissement cardiovasculaire

Les parois artérielles s'épaississent, l'élasticité vasculaire diminue et l'adaptation cardiaque à l'effort est réduite. Il faut distinguer ces changements liés à l'âge des signes pathologiques.

2.3 Vieillissement respiratoire

La capacité respiratoire diminue, l'élasticité pulmonaire se réduit, les échanges gazeux diminuent et la force des muscles respiratoires baisse. Le soignant surveille notamment la dyspnée et participe à la prévention des infections.

2.4 Vieillissement digestif et nutritionnel

L'appétit peut diminuer, des troubles de mastication peuvent apparaître et le transit ralentit, avec risque de constipation. La vigilance infirmière porte particulièrement sur la prévention de la dénutrition et de la déshydratation.

2.5 Vieillissement urinaire et rénal

La fonction rénale diminue progressivement, ce qui augmente la vulnérabilité à la déshydratation. La capacité vésicale réduite entraîne des mictions plus fréquentes. La surveillance de la diurèse et de l'hydratation est essentielle.

2.6 Vieillissement neurologique et sensoriel

Les modifications concernent notamment la mémoire, le sommeil, la vision, l'audition et l'équilibre. Il faut différencier les modifications physiologiques des signes pathologiques.

2.7 Vieillissement endocrinien et immunitaire

Immunosénescence : diminution de la réponse immunitaire associée à une inflammation chronique.

Les modifications métaboliques comprennent un ralentissement thyroïdien et une insulinorésistance. La vulnérabilité aux infections virales et bactériennes est accrue, d'où l'importance de la vaccination et du dépistage précoce.

3. Réserves fonctionnelles, décompensation et modèle de Bouchon

Réserve fonctionnelle : capacité d'un organisme ou d'une fonction à s'adapter et à compenser face à un stress ou une agression.

Décompensation : franchissement d'un seuil fonctionnel lorsque les réserves ne permettent plus de compenser une maladie aiguë ou un événement intercurrent.

Le modèle de Bouchon associe trois niveaux :

1

Élément : Vieillissement physiologique : diminution des réserves.

2

Élément : Maladies chroniques : diminution supplémentaire des réserves.

3

Élément : Maladie aiguë / événement intercurrent : facteur précipitant pouvant entraîner une décompensation.

Chez une personne fragile, un événement intercurrent peut aggraver la dépendance et/ou la maladie et augmenter le risque de dépendance, d'institutionnalisation et de morbidité.

4. Fragilité et vulnérabilité gériatrique

Fragilité : état de vulnérabilité accrue au stress, potentiellement réversible, associé à une diminution des réserves fonctionnelles et à une augmentation du risque de morbi-mortalité.

La prévalence de la fragilité augmente avec l'âge. Son repérage précoce permet d'agir avant l'installation de la dépendance.

4.1 Critères de Fried

Perte de poids

Repère du cours : ≥ 4,5 kg ou ≥ 5 % / an

Fatigue

Repère du cours : ≥ 3 à 4 jours / semaine

Baisse de dépense énergétique

Repère du cours : < 383 kcal/semaine chez l'homme ; < 270 kcal/semaine chez la femme

Baisse de vitesse de marche

Repère du cours : Temps pour marcher 4,57 m, seuil stratifié selon sexe et taille

Force de préhension

Repère du cours : Seuil stratifié selon sexe et IMC

Interprétation : 0 critère = robuste ; 1 ou 2 = pré-fragile ; ≥ 3 = fragile.

5. Syndromes gériatriques et cascade gériatrique

Syndrome gériatrique : manifestation fréquente chez la personne âgée, multifactorielle, rarement expliquée par une seule pathologie, associée à un fort retentissement fonctionnel et nécessitant une prise en soins multidimensionnelle et pluriprofessionnelle.

Cascade gériatrique : enchaînement de complications où un problème initial favorise d'autres syndromes et une perte fonctionnelle progressive.

Principaux syndromes : confusion, trouble neurocognitif, dénutrition, déshydratation, chute, incontinence urinaire, syndrome d'immobilisation. Autres situations citées : ostéoporose, dépression, douleur, sarcopénie, polymédication/iatrogénie, constipation, troubles sensoriels, troubles du sommeil et perte d'autonomie.

6. Confusion aiguë / delirium

Confusion aiguë / delirium : syndrome aigu et fluctuant associant principalement un trouble de l'attention, une perturbation cognitive et une modification possible du niveau de vigilance, installé en quelques heures à quelques jours.

Trois formes : hyperactive (agitation, agressivité, hallucinations), hypoactive (ralentissement, somnolence, retrait ; souvent sous-diagnostiquée) et mixte.

6.1 Terrain prédisposant et causes

Âge > 80 ans

TNC préexistant

antécédent de syndrome confusionnel

fragilité

dénutrition

déficit visuel ou auditif

mobilité réduite / immobilisation

polymédication

troubles de l'humeur

Facteurs précipitants à rechercher : infection, troubles métaboliques, douleur/inconfort, médicaments ou toxiques, chirurgie, hospitalisation, changement brutal d'environnement, privation de sommeil.

6.2 Repérage et CAM

Éléments d'alerte : changement récent du comportement ou des capacités, fluctuations dans la journée, difficulté à maintenir l'attention, désorientation, propos incohérents, vigilance inhabituelle, agitation ou ralentissement inhabituel.

CAM : outil de dépistage de la confusion : 1 + 2 + (3 ou 4), soit début aigu/fluctuation + trouble de l'attention + désorganisation de la pensée ou altération du niveau de vigilance.

Début brutal

TNC majeur : Installation progressive

Fluctuante

TNC majeur : Plus stable à court terme

Attention très perturbée

TNC majeur : Attention parfois longtemps préservée

Cause aiguë à rechercher

TNC majeur : Maladie chronique sous-jacente

TNC majeur : évolution et possibilités thérapeutiques variables selon la cause ; ne pas l'assimiler à la confusion aiguë.

6.3 Conséquences et prise en soins

Conséquences : chute, arrachement de dispositifs, opposition aux soins, fugue/mise en danger, diminution des apports, immobilisation, perte d'autonomie, prolongation d'hospitalisation, complications d'immobilisation, institutionnalisation et déclin fonctionnel.

Prise en soins : traiter la cause avant tout, corriger les conséquences, privilégier les mesures non médicamenteuses. Pas de traitement médicamenteux systématique.

environnement calme

repères temporels et spatiaux, horloge/calendrier

lunettes et appareil auditif

lumière adaptée

favoriser le sommeil nocturne

mobilisation précoce

présence des proches si bénéfique

limiter changements de chambre et interruptions inutiles

favoriser hydratation et alimentation

surveiller douleur, transit et élimination urinaire

limiter les dispositifs invasifs inutiles

7. Troubles neurocognitifs (TNC)

Trouble neurocognitif : diminution acquise des capacités cognitives dans un ou plusieurs domaines.

TNC mineur : déclin cognitif sans perte d'indépendance dans les activités quotidiennes.

TNC majeur : déclin cognitif suffisamment important pour interférer avec l'autonomie.

Les TNC augmentent avec l'âge mais ne font pas partie du vieillissement normal.

7.1 Facteurs de risque et étiologies

Non modifiables : âge, antécédents familiaux/facteurs génétiques, pathologies neurologiques. Potentiellement modifiables : HTA, diabète, hypercholestérolémie, tabagisme, sédentarité, isolement social, déficit auditif non corrigé, dépression, obésité.

Étiologies : neurodégénératives (Alzheimer, corps de Lewy, dégénérescences fronto-temporales, Parkinson et apparentées), vasculaires, toxiques/médicamenteuses, carentielles, endocriniennes/métaboliques, infectieuses et autres causes neurologiques.

7.2 Repérage et évaluation

L'évaluation associe entretien patient/aidant, examen clinique, mémoire, comportement, autonomie, outils cognitifs et fonctionnels et examens paracliniques selon le contexte.

Outils cités : MMSE/MoCA, test des 5 mots, horloge, fluences, ADL, IADL, NPI, GDS. Examens biologiques cités : TSH, NFS, albumine/CRP, calcémie, glycémie, créatinine/clairance ; imagerie :

IRM.

7.3 Conséquences et prise en soins

Conséquences fonctionnelles : difficultés IADL puis ADL, perte progressive d'autonomie, difficultés de gestion des traitements, chute, difficultés alimentaires. Conséquences psychologiques/comportementales : apathie, anxiété, agitation, agressivité, opposition, désinhibition, déambulation, idées délirantes, hallucinations, troubles du sommeil. Conséquences sociales : isolement, difficulté de maintien à domicile, charge pour les aidants, institutionnalisation.

Objectifs : préserver l'autonomie, maintenir les capacités restantes, traiter les pathologies associées, sécuriser l'environnement, prévenir les complications, accompagner le patient et son entourage.

Devant un trouble du comportement : observer → comprendre → rechercher une cause → adapter → réévaluer. Rechercher douleur, infection, constipation, rétention urinaire, faim, soif, fatigue, trouble du sommeil, confusion aiguë, effet médicamenteux ou environnement inadapté.

communication calme et simple

une consigne à la fois

laisser du temps pour répondre

ne pas confronter inutilement

maintenir les routines et repères

activité physique adaptée

activités significatives, musique, promenade selon les goûts

sollicitation adaptée sans mise en échec

implication de l'entourage si bénéfique

8. Dénutrition

Dénutrition : état d'un organisme en déséquilibre nutritionnel, avec bilan énergétique négatif et/ou bilan protéique négatif.

Fréquence citée : domicile 4 à 10 %, hospitalisation 30 à 70 %, institution 15 à 38 %. La dénutrition n'est pas une conséquence normale du vieillissement.

8.1 Facteurs de risque et causes

Elle est le plus souvent multifactorielle : facteurs psycho-socio-environnementaux, affection aiguë ou décompensation chronique, iatrogénie médicamenteuse, troubles bucco-dentaires, régimes restrictifs, troubles neurologiques/cognitifs/psychiatriques, troubles de déglutition et dépendance dans les ADL.

Diminution des apports : maladie aiguë, douleur, nausées/vomissements, dysphagie, problème bucco-dentaire, perte d'appétit, jeûne/examens répétés, changement d'environnement. Augmentation des besoins : infection, inflammation, chirurgie, plaie/escarre, cancer, décompensation chronique. Pertes/mauvaise assimilation : diarrhée, malabsorption/maldigestion.

8.2 Repérage et critères diagnostiques

Rechercher : perte de poids, baisse des prises, perte d'appétit, vêtements trop larges, fonte musculaire, diminution de force, difficulté nouvelle à se lever ou marcher. Peser, connaître le poids habituel, calculer l'IMC, quantifier la perte de poids et surveiller les ingesta.

Critères du cours : présence de critères phénotypiques et étiologiques.

Perte de poids ≥ 5 % en 1 mois ou ≥ 10 % en 6 mois ou ≥ 10 % par rapport au poids habituel

Critères étiologiques : Réduction des apports alimentaires

IMC < 22 kg/m²

Critères étiologiques : Malabsorption / maldigestion

Sarcopénie confirmée

Critères étiologiques : Situation pathologique augmentant les besoins : maladie aiguë, maladie chronique évolutive ou inflammation

8.3 Complications et prise en soins

Complications : infections, chutes/fractures, retard de cicatrisation/escarres, iatrogénie, prolongation d'hospitalisation, augmentation de la morbi-mortalité, fragilité, dépendance/perte d'autonomie et aggravation du pronostic des maladies chroniques.

Corriger les causes ET augmenter les apports : douleur, problèmes bucco-dentaires, dysphagie, nausées/constipation, dépression, médicaments, régimes restrictifs, difficultés fonctionnelles. Adapter aux goûts, enrichir, fractionner, adapter la texture, aider au repas, utiliser les CNO selon indication. Les CNO sont des compléments et non des substituts ; à proposer en collation, à distance des repas (2 h).

9. Déshydratation

Déshydratation : déficit en eau de l'organisme, avec ou sans déficit associé en électrolytes, résultant d'un déséquilibre entre des apports hydriques insuffisants et/ou des pertes hydriques augmentées.

La personne âgée est particulièrement à risque : sensation de soif moins marquée ou retardée, moindre adaptation spontanée des apports, dépendance possible pour accéder aux boissons.

Causes de baisse des apports : anorexie/maladie aiguë, troubles cognitifs, confusion, dysphagie, nausées, dépendance, accès insuffisant aux boissons, jeûne/examens répétés. Pertes augmentées : fièvre, diarrhée, vomissements, forte chaleur, transpiration, diurétiques, polyurie selon contexte.

Signes d'alerte : baisse des apports, fatigue, perte d'appétit, somnolence, modification du comportement, confusion, hypotension, vertiges, diminution des urines. Surveiller quantité réellement bue, diurèse, poids, pression artérielle, fréquence cardiaque, vigilance et muqueuses.

Prise en soins : corriger la cause ; réhydratation orale si possible ; proposer régulièrement de petites quantités ; varier selon les goûts ; faciliter l'accès ; adapter le contenant et la texture en cas de trouble de déglutition.

10. Chutes

Chute : événement au cours duquel une personne se retrouve involontairement au sol ou à un niveau inférieur ; c'est un signal d'alerte gériatrique.

Fréquence citée : 1/3 des plus de 65 ans, 1/2 des plus de 80 ans ; environ 1/2 rechutera. Une chute n'est pas un diagnostic : il faut rechercher pourquoi la personne est tombée.

Facteurs de risque : antécédent de chute, TNC/dépression, arthrose, sarcopénie, troubles de l'équilibre ou de la marche, Parkinson, séquelles d'AVC, baisse visuelle, presbyacousie, dénutrition, polymédication, psychotropes, antihypertenseurs, anticholinergiques.

Hypotension orthostatique : diminution de la PAS ≥ 20 mmHg et/ou de la PAD ≥ 10 mmHg et/ou PAS < 90 mmHg dans les 3 minutes suivant le lever.

Facteurs précipitants : causes médicales aiguës, introduction récente d'un médicament ou augmentation de dose, obstacle, mauvais éclairage, chaussage inadapté, sol glissant, aide technique mal utilisée.

10.1 Évaluation après une chute

Rechercher d'abord une urgence : traumatisme crânien, fracture, douleur importante, déficit neurologique, perte de connaissance, malaise, temps prolongé au sol. Vigilance particulière avec anticoagulants/antiagrégants, traumatisme crânien, impossibilité de relever la personne, douleur ou déformation.

Puis comprendre les circonstances : activité au moment de la chute, prodromes, perte de connaissance, obstacle, médicament récent, chute précédente.

Syndrome post-chute : ensemble associant peur de la verticalisation, rétropulsion, perte des automatismes, diminution de la marche, restriction d'activité et déconditionnement ; il constitue une urgence gériatrique fonctionnelle.

Prévention : corriger les facteurs modifiables, sécuriser l'environnement, maintenir la mobilité, éviter l'alitement injustifié, favoriser le lever et accompagner la marche si nécessaire.

11. Incontinence urinaire

Incontinence urinaire : toute perte involontaire d'urine.

Incontinence urinaire d'effort : fuite lors d'un effort, sans urgenturie préalable.

Incontinence par urgenturie : fuite précédée d'un besoin urgent et difficilement contrôlable.

Incontinence mixte : association de l'incontinence d'effort et de l'incontinence par urgenturie.

Incontinence fonctionnelle : impossibilité d'atteindre les toilettes à temps malgré un appareil urinaire parfois fonctionnel.

Une incontinence d'apparition récente doit faire rechercher une cause réversible avant de conclure à une incontinence chronique. Toujours rechercher une rétention urinaire, notamment en cas de fuites par regorgement.

Rétention aiguë d'urine : impossibilité brutale d'uriner malgré une vessie pleine, avec globe vésical souvent douloureux et palpable ; c'est une urgence thérapeutique.

Prise en soins : traiter la cause, faciliter l’accès aux toilettes, mictions programmées, rééducation/réentraînement. Une sonde vésicale n’est pas indiquée pour traiter une incontinence isolée. Les protections et étuis péniens restent palliatifs en cas d’échec.

12. Syndrome d’immobilisation et escarres

Immobilisation : réduction importante de la mobilité, notamment alitement prolongé ou impossibilité d’assurer les transferts habituels.

Syndrome d’immobilisation : ensemble des conséquences physiques, fonctionnelles et psychologiques liées à une réduction prolongée de l’activité et à l’alitement.

Situations favorisantes : maladie aiguë, douleur, chute/fracture, peur de chuter, déficit neurologique, fatigue, hospitalisation, alitement prescrit ou organisation des soins favorisant l’inactivité. Quelques jours d’alitement peuvent suffire à provoquer un déconditionnement important.

Prévention/prise en soins : lever précoce, transferts, marche quotidienne selon capacités, repas au fauteuil, mobilisation active, bon positionnement, prévention de la douleur, maintien hydratation/nutrition, prévention constipation/fécalome, limitation des dispositifs entravant la mobilité, maintien des repères/interactions, prévention du risque thromboembolique selon le risque.

Escarre : lésion cutanée et/ou des tissus sous-jacents liée principalement à une pression prolongée, éventuellement associée au cisaillement.

Facteurs de risque : immobilité, pression prolongée, dénutrition, déshydratation, incontinence/humidité, altération de la sensibilité, hypoperfusion tissulaire, fragilité cutanée. Zones : sacrum, talons, trochanters, malléoles, coudes.

Repérage : Peau intacte, érythème persistant : rougeur ne blanchissant pas à la pression.

Repérage : Perte cutanée partielle : atteinte superficielle, exposition du derme, possible phlyctène.

Repérage : Perte cutanée totale : toute l’épaisseur de la peau ; tissu adipeux visible possible ; pas d’exposition muscle/tendon/os.

4

Repérage : Perte tissulaire profonde : exposition ou palpation possible du muscle, tendon, cartilage ou os.

Prévention des escarres : inspection de la peau, changements de position adaptés, mobilisation, décharge des zones d’appui, supports adaptés, soins cutanés, gestion humidité/incontinence, hydratation et nutrition adaptées. Échelles citées : Braden et Norton.

13. Autonomie, dépendance et dépendance iatrogène

Iatrogène : Qui est provoquée par un soi nou un traitement medical . Il s’agit d’une consequence indésirable par exemple lié à un medicament ou à une intervention

Autonomie : capacité à décider et agir selon ses choix.

Indépendance fonctionnelle : capacité à réaliser seul les activités de la vie quotidienne.

Dépendance : besoin d’aide pour réaliser certaines activités.

Dépendance iatrogène : perte fonctionnelle provoquée ou aggravée par les soins, l'hospitalisation ou l'organisation des soins.

Facteurs favorisant une dépendance iatrogène : alitement prolongé, limitation des déplacements, sondage urinaire non indispensable ou prolongé, protections systématiques, contention, jeûnes prolongés, privation sensorielle, perte des repères, sommeil perturbé, aide excessive pour la toilette, l'habillage, les transferts ou les repas.

14. Outils de repérage de l'autonomie

ADL : Activities of Daily Living : activités de la vie quotidienne ; évalue notamment toilette, habillage, toilettes, transferts, continence et alimentation.

IADL : Instrumental Activities of Daily Living : activités instrumentales plus complexes, telles que courses, préparation des repas, entretien du logement, lessive, téléphone, transports, prise des médicaments et gestion de l'argent.

AGGIR : Autonomie Gérontologie Groupes Iso-Ressources.

Ces outils participent au repérage de la dépendance et à l'évaluation du niveau fonctionnel.

15. Prévention et rôle infirmier

Les stratégies de prévention visent à maintenir l'autonomie et la qualité de vie : activité physique adaptée, nutrition équilibrée, vaccination, prévention des chutes et maintien du lien social.

L'évaluation infirmière repose sur un recueil de données structuré, une surveillance clinique régulière, le repérage précoce des risques et des transmissions ciblées.

Le rôle infirmier comprend la prévention, l'éducation thérapeutique, l'accompagnement personnalisé, la coordination pluridisciplinaire, ainsi que le respect de l'autonomie et du consentement de la personne âgée.

Connaître l'état fonctionnel et cognitif habituel.

Repérer rapidement tout changement brutal.

Surveiller douleur, hydratation, alimentation, élimination, sommeil, mobilité et peau.

Maintenir lunettes et appareils auditifs.

Favoriser le lever, la marche, les transferts et l'accès aux toilettes.

Éviter l'alitement et les dispositifs invasifs inutiles.

Encourager la participation de la personne aux soins.

Transmettre précisément les modifications observées et alerter en cas de rupture avec l'état habituel.

16. Synthèse : notions essentielles à connaître

Le vieillissement physiologique n'est pas une maladie.

La fragilité expose à la décompensation et peut être potentiellement réversible.

Les syndromes gériatriques sont multifactoriels et interdépendants.

Une confusion aiguë est une urgence diagnostique : rechercher une cause aiguë potentiellement réversible.

Les troubles neurocognitifs ne font pas partie du vieillissement normal.

La dénutrition et l’incontinence ne sont pas des conséquences normales du vieillissement.

Une chute est un signal d’alerte et non un diagnostic.

La prévention de l’immobilisation repose sur une mobilisation précoce et adaptée.

L’hospitalisation et l’organisation des soins peuvent favoriser la dépendance iatrogène.

Chez la personne âgée : rechercher la cause, prévenir la cascade gériatrique et préserver l’autonomie.

17. Cas clinique transversal du cours

Mme B., 88 ans, vit à domicile. Avant l’hospitalisation, elle marchait avec une canne, allait seule aux toilettes et mangeait seule. Hospitalisée depuis 3 jours pour une pneumopathie, elle présente une confusion avec agitation nocturne, une baisse des apports alimentaires et hydriques, reste au lit, porte désormais une protection « par sécurité », présente une rougeur talonnière et tente de se lever seule.

Questions à travailler : quels syndromes gériatriques identifier ? Quels facteurs déclenchants/causes rechercher ? Quelles mesures immédiates mettre en place ? Qu’est-ce qui est potentiellement iatrogène ?

Liens à retenir

Différencier

Le vieillissement est hétérogène. La baisse des réserves rend l'adaptation à un stress moins facile ; elle ne suffit pas à expliquer tout symptôme. Une perte fonctionnelle brutale impose de rechercher une cause. Fragilité, dépendance et autonomie ne sont pas synonymes.

Modèle de Bouchon

Le vieillissement réduit les réserves ; les maladies chroniques les diminuent davantage ; un événement aigu peut faire franchir un seuil de décompensation. Repérer tôt le facteur déclenchant permet de limiter la cascade gériatrique.

Confusion

Un trouble récent et fluctuant de l'attention ou de la vigilance fait rechercher une confusion aiguë, y compris sous une forme peu agitée. Connaître l'état habituel, alerter et rechercher les causes avec l'équipe. Préserver repères, sommeil, lunettes, audition et présence rassurante.

Nutrition et hydratation

Surveiller poids, évolution des apports, accès aux boissons et difficultés de déglutition. Chez la personne de 70 ans et plus, le diagnostic de dénutrition associe au moins un critère phénotypique et un critère étiologique. Le MNA est un dépistage, pas ce diagnostic à lui seul.

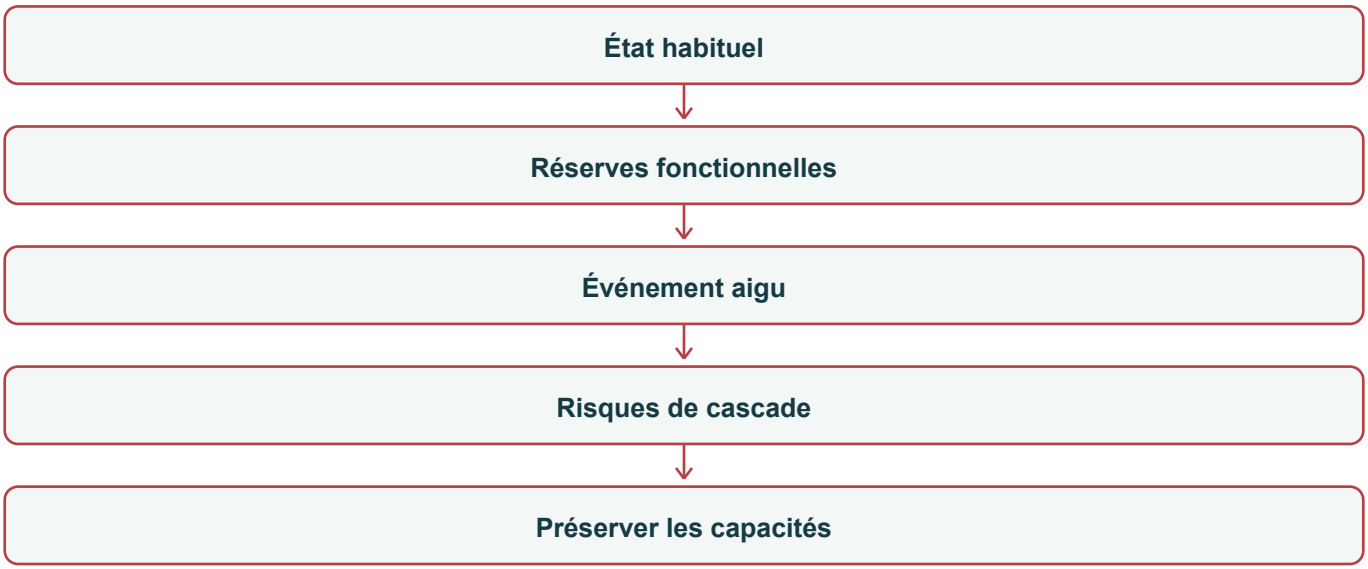
Mobilité et élimination

Rechercher les causes d'une chute et maintenir une mobilité sécurisée. Faciliter l'accès aux toilettes ; ne pas imposer une protection ou une sonde par routine. L'aide excessive et l'alitement injustifié peuvent aggraver la dépendance.

Rôle infirmier

Comparer au fonctionnement antérieur, repérer les ruptures, prévenir douleur, déconditionnement et lésions de pression. Solliciter ce que la personne peut faire, respecter ses choix et coordonner avec l'entourage et l'équipe.

Schéma et vérification des acquis



Questions et réponses

Confusion aiguë = vieillissement normal ? Non.

Fragilité = dépendance certaine ? Non.

Prévenir les chutes signifie-t-il empêcher de marcher ? Non : adapter et sécuriser la mobilité.

Sources et portée

UE B1 CM Veillisement physiologique et pathologique.docx

Ressource Moodle correspondante